

Ocena somatyczna

Każdy pacjent z bulimią powinien mieć ocenę medyczną przed psychoterapią. Elektrolity, EKG, ocena stomatologiczna, ginekologiczna. Hipokaliemia = pilne.

CZAS: 30 min + laboratoryjnie Przed CBT-E · co 3 mies. przy aktywnych objawach

ŹRÓDŁO: Mehler & Andersen (2017); NICE (2017); AED (2021)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **siedem obszarów oceny medycznej** (sekcja 1), zobacz **wartości alarmowe** wymagające pilnej interwencji (sekcja 2). Sekcja 3 — Twoja lista do zabrania na wizytę. Sekcja 4 — notatki po konsultacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Każdy pacjent z bulimią powinien być **oceniony medycznie** przed rozpoczęciem psychoterapii, szczególnie jeśli: wymiotuje > 3x/tyg., używa środków przeczyszczających lub diuretyków, ma objawy alarmowe (omdlenia, kołatania, skurcze, krwawienia), lub jest w ciąży. Mehler & Andersen (2017, „*Eating Disorders: A Guide to Medical Care*”): multisystemowe konsekwencje bulimii wymagają **regularnego monitoringu** — terapeuta i lekarz pracują w zespole. NICE (2017): zaniedbanie oceny medycznej jest **jednym z głównych błędów** w leczeniu ED — pacjent z hipokaliemią ma realne ryzyko arytmii i nagłego zgonu sercowego. **Wartości alarmowe** wymagające pilnej hospitalizacji: $K^+ < 3,0$ mmol/l, QTc > 470 ms, ortostatyczne spadki ciśnienia, omdlenia. Konsultacja medyczna **nie zastępuje** terapii — działa **obok** niej, jako warunek bezpiecznego leczenia. Wstyd często prowadzi do ukrywania pełnego obrazu objawów przed lekarzem — to działa przeciwko Tobie. Otwartość chroni Twoje zdrowie.

01 = Siedem obszarów oceny medycznej

1 · ELEKTROLITY

Potas (K⁺), sód (Na⁺), chlorki (Cl⁻), wodorowęglany. Hipokaliemia z wymiotów (40–50% pacjentów). Zasadowica metaboliczna.

2 · EKG

Ocena QTc, rytmu. Hipokaliemia + wymioty + ćwiczenia kompensacyjne = ryzyko arytmii. QTc > 470 ms = ryzyko torsade de pointes.

3 · MORFOLOGIA + WĄTROBA

Morfologia z rozmazem, magnez, fosfor, kreatynina, mocznik, glukoza, próby wątrobowe (AST, ALT). Bazowy obraz.

4 · TARCZYCA

TSH, FT4 — wykluczenie nadczynności tarczycy (która może maskować ED objawami utraty masy).

5 · STOMATOLOGIA

Ocena erozji szkliwa (62% pacjentów wymiotujących), próchnicy, nadwrażliwości. Stomatolog ED-świadomy. Konsultacja co 6 mies.

6 · GINEKOLOGIA (KOBIETY)

Zaburzenia miesiączkowania (40–50%), niepłodność subkliniczna. Test ciążowy przed terapią. Konsultacja przy planowaniu ciąży.

7 · OCENA OGÓLNA · GABINETOWA

Tętno, ciśnienie (siedząc i stojąc — test ortostatyczny), masa ciała (bez fokus klinicznego), badanie fizykalne. Objawy: omdlenia, kołatania, skurcze, znak Russella (otarcia na grzbiecie dłoni).

02 ✕ Wartości alarmowe — pilna interwencja

PILNA HOSPITALIZACJA

- $K^+ < 3,0$ mmol/l
- QTc > 470 ms
- Ortostatyczne spadki ciśnienia
- Omdlenia
- Krew w wymiotach lub stolcu
- Bóle w klatce piersiowej

WYMAGA ŚCISŁEGO MONITORINGU

- $K^+ 3,0\text{--}3,5$ mmol/l (uzupełnienie + kontrola)
- QTc 440–470 ms
- Wahania ciśnienia
- Skurcze mięśni, drętwienia
- Powiększenie ślinianek
- Znak Russella

03 ✎ Moja lista na wizytę u lekarza

Wstyd często prowadzi do ukrywania pełnego obrazu objawów przed lekarzem. To działa przeciwko Tobie — lekarz **potrzebuje** pełnej informacji, by zaplanować właściwą diagnostykę. Twoja otwartość chroni Twoje zdrowie.

MOJE ZACHOWANIA KOMPENSACYJNE

— *jakie, jak często, od kiedy; bez ocen, tylko fakty*

OBJAWY FIZYCZNE, KTÓRE ZAUWAŻAM

— *zęby, miesiączki, zmęczenie, kołatania, ból brzucha, omdlenia*

04 ✎ Notatki po wizycie

CO ZOSTAŁO ZLECONE, CO WYMAGA OBSERWACJI

— *badania, kontrole, daty, znalezione wyniki nieprawidłowe*

Klucz: ocena somatyczna *nie* jest „dodatkową przeszkodą” do leczenia — jest **warunkiem** bezpiecznego leczenia. Bulimia ma realne konsekwencje fizyczne, z których część zagraża życiu (arytmie z hipokaliemii). Mehler & Andersen (2017): zespół zintegrowany (terapeuta + lekarz POZ + ewentualnie dietetyk ED-świadomy + stomatolog) daje **znacząco lepsze** wyniki niż samodzielna terapia. Każdy z tych specjalistów widzi inną część obrazu — razem tworzą pełen plan. **Dobra wiadomość:** większość konsekwencji somatycznych bulimii jest *odwracalna* — elektrolity, EKG, miesiączki, ślinianki wracają do normy w ciągu tygodni-miesięcy po zaprzestaniu kompensacji i regularnym jedzeniu. Trwałe są tylko niektóre: erozja zębów. To kolejny argument za wczesnym leczeniem. Konsultacja medyczna *nie* jest oceną moralną — lekarz nie ocenia, lekarz *chroni* Twoje zdrowie. Pierwszy krok — kontakt z lekarzem POZ lub specjalistą ED.